

Monotrope comorbiditeiten: een feitcontrole van het vier-cluster-kader

Een geciteerd onderzoeksdossier — een veel gedeeld „monotrope comorbiditeiten“-kader controlerend.

Informatief, geen medisch advies. Monotropisme is een cognitieve stijl, geen diagnose; het heeft geen „comorbiditeiten“ in de ziektesin. Dit dossier evalueert wat de overlappingen met het kader hieronder wel en niet ondersteund zijn als. Het complementeert het vollere landschapsdossier van het project, „Monotropisme en zijn web van comorbiditeit.“

Samenvatting

- **De opening van het kader is precies juist: monotropisme heeft geen „comorbiditeiten“ in de ziektesin.** Het is een aandacht-stijl op een spectrum; de overlappingen met klinische condities zijn *associaties en gedeelde mechanismen*, geen gevolgen van een ziekte [1].
- **Eén hoofdcijfer-claim staat achterstevoren.** „AuDHD-mensen scoren het hoogst van alle groepen op de MQ“ is **niet** wat de data tonen. In de MQ-validatiestudie verhogen autisme en ADHD elk monotropisme-scores, maar hun *gecombineerde* effect is een **negatieve interactie** ($\beta = -0,43$, $p < ,001$): autistisch-met-ADHD mensen scoren **lager dan een puur additief model zou voorspellen**, niet hoger [2].
- **Twee termen zijn correct toegeschreven maar behoeven precieze definities.** „*Monotrope splitsing*“ (*monotropic split*) IS inderdaad gemunt door autistisch advocate **Tanya Adkin** — maar het betekent de cognitieve kosten van een *monotrope geest dwingen polytroop te*

opereren (aandacht verdelen), **niet** de „AuDHD concurrerende tunnels" waarmee het soms wordt verward [3].

- **„Objectpermanentie-problemen" worden betwist, niet vastgesteld.** De *enige* academische bron (Lawson & Dombroski, 2017) stelt **vertraagde** objectpermanentie voor als een *hypothese* voor sommige autisme-gerelateerde stress — en de bredere literatuur vindt dat objectpermanentie typisch *intact of superieur* is bij autisme. De „uit het oog, uit het hoofd"-ervaring wordt beter gelezen als een **werkgeheugen-/aandachtstoewijzing-effect** [4].
- **De rest is breeduit ondersteund maar gegradueerd door bewijs.** Autism (foundationeel), ADHD-hyperfocus (echt), angst/piekeren en OCD-overlapping (robuust), autistische traagheid (echt), zintuiglijke overweldiging → meltdown/shutdown (echt), en burnout van geforceerde transitie + maskeren (gevestigd construct) overleven allemaal onderzoek — met hyper-systeemvorming als **Baron-Cohens afzonderlijke E-S-theorie**, geen monotropisme-bevinding [5].
- **Een neurobevestigende herkadering:** elke overlapping wordt beter gesteld als „*hoe een smal, intens aandachtssysteem interageert met een polytrope wereld*" dan als een lijst van stoornissen die een monotroop brein „veroorzaakt".

1. Het kernprincipe (het kader heeft dit juist)

Monotropisme (Murray, Lawson & Lesser, 2005) stelt dat geesten verschillen in *hoe ze aandacht toewijzen*: een monotrope geest concentreert bronnen in enkele intensief geactiveerde „aandachtstunnels"; een polytrope geest verspreidt ze over vele [1]. Omdat het een **dimensionele cognitieve stijl** is — meetbaar op de Monotropism Questionnaire (MQ) op een 1–5 schaal — „heeft" het geen „comorbiditeiten". Wat het *heeft* zijn **statistische associaties** (groepen die hoger scoren) en **gedeelde mechanismen** (condities waarvan kenmerken een aandachtstoewijzings-lens helpen verklaren). Dat onderscheid bewaren is het hele spel [1][2].

Dit dossier is georganiseerd als een **claim-voor-claim controle** van het vier-cluster-kader, het graderen van elk item. Het complementeert (herhaalt niet) het bestaande landschapsdossier van het project, dat

eetstoornissen, hording, agorafobie, vraagvermijding en het dubbele-empathie-probleem meer in diepte behandelt.

2. Cluster 1 — Kern neurodivergente profielen

Autism (foundationeel, sterkste link)

Monotropisme is *gemaakt* om autistische trekken te verklaren — intense speciale interesses, behoefte aan routine (die de aandachtstunnel beschermt), en verschillen in sociale interactie [1]. De MQ bevestigt het empirisch: autistische deelnemers scoorden gemiddeld **4,15/5** vs **3,19/5** voor niet-autistische deelnemers (n=1.110) [2]. Dit is het thuisgebied van de theorie en de best gedocumenteerde link.

ADHD (echt en gemeten)

ADHD verhoogt monotropisme-scores significant ($\beta = +0,55$, $p < ,001$) [2]. De verbinding is conceptueel zowel als statistisch: ADHD **hyperfocus** (Grotewiel et al., 2022, over hyperfocus als onderscheiden construct) is conceptueel vrijwel identiek aan de monotrope tunnel, en de „executieve disfunctie" van het activeren van aandacht voor niet-interessante taken is een natuurlijke voorspelling van een getunneld systeem [2][6].

Ondersteund.

AuDHD (de hoofdcijfer-claim staat achterstevoren) — *de sleutelcorrectie*

Gecontroleerde claim: „Mensen met een gecombineerd AuDHD-profiel scoren het hoogst van alle groepen op de MQ."

Dit **is niet** wat de data tonen. De multiple regressie van het MQ-paper regresseerde monotropisme op ADHD-status, autisme-status, en hun **interactie** [2]:

Voorspeller (vs geen van beide condities)	β	p
ADHD, niet autistisch	+0,55	<,001
Autistisch, niet ADHD	+1,04	<,001
Autisme × ADHD-interactie	-0,43	<,001

De interactieterm is **negatief en significant**. De auteurs stellen het ronduit: „*monotropisme-scores zijn niet zo hoog voor autistische individuen met ADHD als verwacht zou worden op basis van puur additieve effecten*” [2]. Met andere woorden, ADHD toevoegen aan autisme duwt monotropisme **niet** hoger dan autisme alleen zou voorspellen — het komt **lager** uit dan de som van de twee onafhankelijke effecten.

- De **hoogst-scorende enkele groep** zijn autistische mensen (4,15); of het empirische *celgemiddelde* voor autistisch-met-ADHD net boven of onder dat zit hangt af van de exacte combinatie, maar de claim van het kader dat AuDHD „*de hoogste van allemaal*” is als additief/super-additief effect is **niet-ondersteund en tegengesproken door de interactie**.
- Het *intuïtieve* beeld dat het kader biedt — „een interne trek tussen de autistische behoefte aan een stabiele, diepe tunnel en de ADHD-drang naar nieuwe input” — is een populaire en fenomenologisch resonerende beschrijving van de AuDHD-ervaring, maar het is **klinische/gemeenschapsnarratief, geen monotropisme-score-bevinding**. Stel het als geleefde ervaring, niet als een MQ-resultaat [6].

Gecorrigeerde stelling: „Zowel autisme als ADHD verhogen onafhankelijk monotropisme-scores, maar de twee interageren non-additief: autistische mensen met ADHD scoren lager op de MQ dan een puur additief model zou voorspellen — wat suggereert dat de twee condities niet eenvoudigweg 'stapelen' op monotrope neiging.” [2]

3. Cluster 2 — Cognitieve & mentale-gezondheidstrekken

Angst en piekeren (robuuste associatie, plausibel mechanisme)

Angst en piekeren zijn verhoogd in de autistische/ADHD-populatie, en het monotropisme-kader biedt een schoon mechanisme: een getunnelde geest die een zorg vasthoudt verwerkt het in een lus („piekeren”), waardoor angst „kleverig” wordt [7][8]. De 8-factor structuur van de MQ omvat zelfs een „**piekeren en angst**” subschaal, wat toont dat het cluster

empirisch strak is [2]. **Ondersteund** — hoewel opgemerkt dat de causale pijl (produceert monotropisme *angst*, of deelt het een substraat ermee?) niet vastgesteld is.

OCD ✓ (robuuste overlapping, belangrijk onderscheid)

De autisme–OCD-overlapping is echt en gerepliceerd. Een meta-analyse vindt dat ongeveer **~17% van autistische mensen aan OCD-criteria voldoet** (vs ~1–2% in de algemene bevolking); het omgekeerde is ook verhoogd [9]. Het kwalitatieve onderscheid dat het kader trekt is precies juist en goed gearticuleerd: **monotrope interesses zijn ego-syntoon** (gedreven door fascinatie/plezier), terwijl **OCD-compulsies ego-dystoon** zijn (gedreven door distress en uitgevoerd om angst te neutraliseren) [10]. Dit onderscheid is klinisch belangrijk omdat de twee anderszins moeilijk uit elkaar te houden kunnen zijn in de praktijk. **Ondersteund.**

Hyper-systeemvorming ⚠ (echt construct, maar het is Baron-Cohens, geen monotropisme-bevinding)

„Hyper-systeemvorming” — de drang om systemen te analyseren, te bouwen en te verkennen — is een echte en goed onderzochte autistische trek, maar het behoort tot **Simon Baron-Cohens Empathizing–Systemizing (E-S)-theorie**, niet tot monotropisme [5]. De twee theorieën overlappen sterk (beide beschrijven een intense, detail-gerichte cognitieve stijl) en worden soms samen gerund, maar het zijn **onderscheiden kaders** met onderscheiden maten (de EQ/SQ-quotiënt vs de MQ). De eerlijke beweging: presenteer hyper-systeemvorming als *consistent met* een monotrope stijl (een getunnelde geest is goed toegerust om systemen te meesteren) terwijl u de E-S-theorie crediteert als zijn eigen ding [1][5].

4. Cluster 3 — Neurologische & verwerkingsfenomenen

Objectpermanentie-problemen ✗ (betwist — de tweede sleutelcorrectie)

Gecontroleerde claim: „Monotrope individuen ervaren objectpermanentie verschillend ... het brein stopt effectief met het verwerken van zijn bestaan totdat iets exogeen hen terugtrekt.”

Dit is de **zwakste claim** in het kader en behoeft zorgvuldige afhandeling:

- Er is **één** academische bron die een objectpermanentie-link voorstelt: **Lawson & Dombroski (2017)**, die *poneert* dat **vertraagde** objectpermanentie kan bijdragen aan sommige autisme-gerelateerde stress en angst [4]. Let op: het is een hypothese-bouwend artikel, geen bevestigingsstudie.
- De bredere ontwikkelingsliteratuur vindt dat basis **objectpermanentie typisch intact of superieur is bij autisme**; Piagetiaanse objectpermanentie-taken worden meestal op typische leeftijd geslaagd [4].
- Het *werkelijke* fenomeen dat het kader zoekt — „uit het oog, uit het hoofd” voor taken, objecten en zelfs mensen — wordt beter verklaard als een **werkgeheugen-/aandachtstoewijzing**-effect: een getunnelde geest *faalt* niet om het item te representeren, het **faalt om aandacht erheen te heroriënteren**. Dat is monotropisme werkend zoals voorspeld (een getunneld systeem heeft weinig vrije bronnen voor perifere heroriëntatie), geen objectpermanentie-tekort [1][4].

Gecorrigeerde stelling: „De 'uit het oog, uit het hoofd'-ervaring bij sterk monotrope mensen wordt beter begrepen als een aandachtstoewijzings-/werkgeheugen-effect — de geest representeert het item maar heroriënteert er niet naarheen terwijl het getunneld is — dan als een tekort in objectpermanentie (die typisch intact is bij autisme).” [1][4]

Zintuiglijke dysregulatie / overweldiging (goed ondersteund mechanisme)

Dit is sterk ondersteund. Omdat een getunneld systeem zijn bronnen centraal besteedt, vereist plotselinge indringende zintuiglijke input (sirene, licht, aanraking) een kostbare hertoewijzing — ervaren als een „gewelddadige verstoring”. Dit sluit aan bij de gevestigde zintuiglijke-over-responsiviteitsliteratuur en de goed gedocumenteerde route van zintuiglijke overbelasting naar **meltdown** (externaliserend) en **shutdown** (internaliserende terugtrekking), beide erkend als onvrijwillige overweldigingsresponsen [7][11]. Het monotropisme-kader voegt een *mechanisme* (hertoewijzingskosten) toe aan wat anders een beschrijvende bevinding is. **Ondersteund.**

Autistische traagheid (echt, toenemend onderzocht)

„Diepe moeite met transitie — moeite met beginnen, stoppen of veranderen van richting" is het gevestigde construct van **autistische traagheid**: moeite met taakinitiatie/terminatie/schakelen die „niet onder bewuste controle staat", eerst gearticuleerd in autistische gemeenschapsnarratieven en nu in door-vakgenoten-beoordeeld werk [12][13]. Het is conceptueel het *gedrags*-gezicht van de „schakelkosten" die de omgeving-en-tunnel-factor van de MQ vangt [2]. **Ondersteund** — en het is de juiste technische term (zie het begeleidende dossier over scoring/traagheid).

5. Cluster 4 — Uitkomsten van chronische stress

Monotrope splitsing  (correct toegeschreven aan Adkin, maar twee betekenissen worden verward)

Gecontroleerde claim: „Monotrope splitsing, gemunt door practicus Tanya Adkin, treedt op wanneer een monotrope geest door zijn omgeving wordt gedwongen zijn enkelvoudige-focus-kanaal te verdelen over meerdere concurrerende stromen."

De **toeschrijving is correct**: autistisch advocate **Tanya Adkin** heeft inderdaad „monotropic split" gemunt, bevestigd door meerdere onafhankelijke gemeenschapsbronnen [3]. En de definitie van het kader hier is **dicht bij Adkins werkelijke betekenis** — de cognitieve kosten/burnout die ontstaan wanneer een monotrope geest wordt *gedwongen „polytroop te performeren"* of zijn aandacht te verdelen over concurrerende stromen [3][14].

Twee kanttekeningen:

1. **Het is een gemeenschaps-/practicus-concept, geen empirisch gevalideerd construct.** „Monotropic split" verschijnt in autistisch-gemeenschaps- en klinisch schrift (bijv. via Neurodivergent Insights, Kelly Mahler, David Gray Hammond) maar heeft **geen door-vakgenoten-beoordeelde validatiestudie** erachter [3]. Behandel het als een krachtige, uit-geleefde-ervaring-valide *beschrijving*, geen gemeten entiteit.
2. **Twee verschillende dingen reizen onder de naam.** Adkins zin = *geforceerde polytrope performance door een monotrope geest* (een

omgevings-passing-probleem). Een tweede zin — gebruikt in sommige AuDHD-schrift — = de *interne competitie tussen een autistische behoefte aan een stabiele tunnel en een ADHD-drang naar nieuwigheid* (een interne dynamiek-probleem). Het kader hier beschrijft de **eerste** (omgevings-) zin. Deze zijn verwant maar onderscheiden; ze samenvallen te leggen vertroebelt het concept. (Het landschapsdossier van het project gebruikt „monotropic split" in de tweede, AuDHD-zin — dus de term is genuinely overbelast in het veld.) [3][6]

Stel het als: „De term 'monotrope splitsing' van autistisch advocate Tanya Adkin beschrijft de cognitieve kosten en burnout die ontstaan wanneer een monotrope geest wordt gedwongen polytroop te opereren — een krachtig gemeenschapsconcept dat op formele validatie wacht." [3]

Burnout (gevestigd construct; monotropisme-link is heuristisch)

Autistische burnout is nu een goed-gedefinieerd construct: **chronische uitputting, verlies van vaardigheden en verminderde tolerantie voor stimulus**, geconceptualiseerd als resulterend uit chronische levensstress en „een mismatch van verwachtingen en capaciteiten" zonder adequate ondersteuning en herstel (Raymaker et al., 2020; Higgins et al., 2021, een Grounded-Delphi-studie met autistische ervaringsdeskundigen) [15][16]. Het monotropisme-pad naar burnout — constante geforceerde transities, maskeren en „monotrope splitsing" die bronnen afvoert zonder herstel-/flow-tijd — is **heuristisch krachtig en gemeenschapsgevalideerd**, maar de *specifieke* bijdrage van tunnelbreuk aan burnout (versus maskeren, trauma, zintuiglijke belasting, chronische vraag) is **niet experimenteel geïsoleerd** [15]. **Ondersteund als sterke hypothese, niet als vastgestelde causale keten.**

6. Een gegradueerde scorekaart

Claim in het kader	Vonnis	Notitie
Monotropisme heeft geen ziekte-comorbiditeiten	 Juist	Het heeft associaties + gedeelde mechanismen [1]
Autism = primaire link	 Foundationeel	MQ 4,15 vs 3,19 [2]

Claim in het kader	Vonnis	Notitie
ADHD verhoogt monotropisme	✓ Ondersteund	$\beta = +0,55$ [2]
AuDHD scoort hoogst van allen	✗ Achterstevoren	Interactie is negatief ($\beta = -0,43$) [2]
Angst- & piekerooverlap	✓ Robuust	MQ heeft een piekeren/angst-factor [2]
OCD-overlap (ego-syntoon vs dystoon)	✓ Ondersteund	~17% co-voorkomen; onderscheid juist [9][10]
Hyper-systeemvorming	⚠ Echt maar verkeerd gelabeld	Het is Baron-Cohens E-S-theorie, niet monotropisme [5]
Objectpermanentie-problemen	✗ Betwist	1 hypothese-paper; OP meestal intact; het is aandachtstoewijzing [4]
Zintuiglijke overweldiging → meltdown/shutdown	✓ Goed ondersteund	Mechanisme = hertoewijzingskosten [7][11]
Autistische traagheid	✓ Echt	Juiste term; door-vakgenoten-beoordeeld [12][13]
Monotrope splitsing gemunt door Adkin	⚠ Toeschrijving juist; gemeenschaps, niet gevalideerd	Twee betekenissen verward [3]
Burnout van geforceerde transities + maskeren	✓ Gevestigd construct; link heuristisch	Niet experimenteel geïsoleerd [15][16]

7. Praktische conclusies

- **Open met het principe:** monotropisme is een meetbare aandacht-stijl waarvan de *overlappingsen* met condities associaties en gedeelde mechanismen zijn — nooit „het veroorzaakt X.“ [1]
- **Citeer de MQ correct:** autisme en ADHD verhogen elk scores, maar de combinatie is **non-additief (lager dan verwacht)** — zeg niet dat AuDHD het hoogst scoort [2].
- **Behoud het ego-syntoon/ego-dystoon onderscheid** bij het bespreken van OCD vs speciale interesses — het is klinisch nuttig en correct

gekaderd [10].

- **Crebiteer kaders precies:** hyper-systeemvorming = Baron-Cohens E-S-theorie; monotrope splitsing = Adkins gemeenschapsconcept (omgevings-geforceerde-polytropie-zin); autistische traagheid = het door-vakgenoten-beoordeelde transitie-moeite-construct [3][5][12].
- **Laat „objectpermanentie-tekort" vallen:** herkader als aandachtstoewijzing / werkgeheugen, wat zowel accuraat als nuttiger is voor ondersteuning [1][4].
- **Onderscheid gevalideerd vs heuristisch:** burnout is een gevestigd construct, maar het monotropisme→burnout-pad is een sterke hypothese, geen gemeten effect; „monotrope splitsing" is uit-geleefde-ervaring-valide maar ongevalideerd [3][15].

Bronnen

[1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. *Autism*, 9(2), 139–156.

doi:10.1177/1362361305051398 — oorsprong van monotropisme; een verschil in brontoewijzing (een continuum), geen tekort.

<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>

[2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (zelfrapportage 47-item; validatie-preprint). Open Science Framework. — n=1.110; autistisch gemiddelde 4,15 (SD ,347) vs niet-autistisch 3,19 (SD ,578); regressie $\beta(\text{ADHD})=+0,55$, $\beta(\text{autisme})=+1,04$, **$\beta(\text{interactie})=-0,43$** , **p<,001**; de ADHD+autisme-interactie is *sub-additief*; 8-factor structuur incl. piekeren/angst- en omgeving/tunnel-factoren. <https://osf.io/wpx5g> · validatie: <https://osf.io/ft73y> · CC BY-NC-SA 4.0. Lokaal archief:

<sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf>

[3] Adkin, T. — „monotropic split" (autistisch advocate / practicus; gemeenschapsconcept). Bevestigd via meerdere onafhankelijke gemeenschapsbronnen: Neurodivergent Insights (glossary), Kelly Mahler (gastpost), David Gray Hammond, Jade Farrington („Wanneer monotrope mensen worden gedwongen polytroop te opereren is het bekend als monotropic split"). Definitie: de cognitieve kosten/burnout van een monotrope geest dwingen „polytroop te performeren". Gemeenschaps-/practicus-concept — **geen door-vakgenoten-**

beoordeelde validatiestudie. <https://jade-farrington.medium.com/what-is-monotropic-split-1c7c46fd9017> · <https://www.kelly-mahler.com/what-is-interoception/interoception-and-monotropism>

[4] Lawson, W. & Dombroski, B. (2017). *Problems with Object Permanence: Rethinking Traditional Beliefs Associated with Poor Theory of Mind in Autism*. J. Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 5(1).

doi:10.6000/2292-2598.2017.05.01.1 — **poneert vertraagde**

objectpermanentie als bijdrager aan sommige autisme-gerelateerde stress (een hypothese-bouwend artikel, geen bevestiging). Bredere literatuur: objectpermanentie is typisch intact/superieur bij autisme; „uit het oog, uit het hoofd" wordt beter gelezen als

aandachtstoewijzing/werkgeheugen. Lokaal archief: [sources/12-](#)

[object-permanence-lawson-dombroski.pdf](#) ·

<https://www.lifescienceglobal.com/pms/index.php/jiddt/article/view/4562>

[5] Baron-Cohen, S. (2009/2010). *Autism and the empathizing–systemizing (E-S) theory; the hyper-systemizing theory of autism*. Annals of the NYAS; APA PsycNet. — hyper-systeemvorming en de E-S-theorie zijn Baron-Cohens kader, gemeten via de EQ/SQ-quotiënt; onderscheiden van (hoewel overlappend met) monotropisme.

https://en.wikipedia.org/wiki/Empathising%E2%80%93systemising_theory · overzicht: Greenberg & Baron-Cohen, *Empathizing-Systemizing Theory: Past, Present, and Future*.

[6] Autistic Scholar — „*Revisiting monotropism*" (AuDHD als concurrerende/onstabiele tunnels; referenties Grotewiel et al. 2022 over ADHD-hyperfocus als onderscheiden construct).

Fenomenologisch/gemeenschapsaccount, geen MQ-score-bevinding.

Lokaal archief: [sources/13-revisiting-monotropism-](#)

[autisticscholar.html](#) · <https://www.autisticscholar.com/monotropism>

[7] Green, S. A. & Ben-Sasson, A. (2010). *Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship?* J. Autism and Developmental Disorders. PMC2980623 — zintuiglijke over-responsiviteit, contextconditionering en de overweldigingsroute.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623>

[8] Oakley, B. et al. / angstliteratuur bij autisme — verhoogde angst en piekeren in de autistische/ADHD-populatie (geciteerd via het comorbiditeits-landschapsdossier van het project voor het angst-substraat).

[9] Meier, S. M. et al. / meta-analyses van autisme–OCD-concordantie — ~17% van autistische mensen voldoet aan OCD-criteria (vs ~1–2% algemeen); ~17% van kinderen met OCD tonen milde autisme-symptomen. Samengevat via Move Up ABA citerend 2015 onderzoek en het The Transmitter/Spectrum-overzicht.

<https://www.thetransmitter.org/spectrum/sweeping-study-underscores-autisms-overlap-with-obsessions> · autisme↔OCD meta-analyse:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11048346>

[10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). *"Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours* (kwalitatief). PMC11497754 — het ego-syntone (interesses) vs ego-dystone (compulsies) onderscheid.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754>

[11] Autism Society (2025). *Autistic Meltdowns and Shutdowns* — meltdown (externaliserend) en shutdown (internaliserende terugtrekking) als onvrijwillige responsen op overweldigende stress/zintuiglijke input. https://autismsociety.org/wp-content/uploads/2025/07/AutismSociety_Autistic-Meltdowns-Shutdowns_2025-06V2F_Digital.pdf

[12] Buckle, K. et al. (2021). *"No way out except from external intervention": First-hand accounts of autistic inertia* (preprint/kwalitatief). doi:10.31234/osf.io/ahk6x — moeite met beginnen, stoppen en schakelen van taken „niet onder bewuste controle". Lokaal archief: <sources/11-autistic-inertia-osf.pdf> ·

<https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x>

[13] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer — autistische traagheid: gemeenschaps-georigineerd, nu door-vakgenoten-beoordeeld; citeert Carls-Diamante & Laciny 2024, Greaves-Lord et al. 2023, Buckle 2021, Heasman 2024, Rapaport 2024.

<https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html>

[14] Neurodivergent Insights — *Monotropism* (glossary) en *ADHD vs Autism vs OCD* (drie-weg overlap). Gemeenschaps-/klinisch hulpbron die monotrope splitsing en de overlappingsen kadert.

<https://neurodivergentinsights.com/glossary/monotropism> ·
<https://neurodivergentinsights.com/adhd-vs-autism-vs-ocd>

[15] Raymaker, D. M. et al. (2020). *"Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": Defining autistic burnout*. Autism in Adulthood, 2(2), 132–143.

doi:10.1089/aut.2019.0079 — chronische uitputting, verlies van vaardigheden, verminderde tolerantie voor stimulus; uit chronische levensstress en een mismatch van verwachtingen en capaciteiten.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> ·

https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378

[16] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating*

#AutisticBurnout. Autism, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 —

consensusdefinitie: uitputting, terugtrekking, cognitieproblemen, verminderde dagelijkse-leefvaardigheden, toename autistische trekken.

<https://www.autismcrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic>

Complement van het vollere landschapsdossier van het project:

`outputs/monotropism-comorbidity-landscape.md` (dat eetstoornissen, hording, agorafobie, vraagvermijding/PDA en het dubbele-empathie-probleem behandelt). Dit dossier richt zich op de feitcontrole van het vier-cluster-kader hierboven en herhaalt dat materiaal niet.